TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
27ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

SENTENÇA

Processo nº:	**1167687-39.2024.8.26.0100**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar**
Requerente:	**Sandra Eugênia Graça Binas**
Requerido:	**Notre Dame Intermédica Saúde S.A**

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Melissa Bertolucci**

Vistos.

Sandra Eugênia Graça Binas propôs ação em face de Notre Dame Intermédica Saúde S.A, aduzindo, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde da Requerida, adimplente com as mensalidades desde a contratação em 21/12/2018. Afirma que foi diagnosticada em 05/05/2022 com neoplasia maligna de mama esquerda (CID10 C50.9), foi submetida a tratamentos intensivos, incluindo quimioterapia, mastectomia e, posteriormente, medicamentos prescritos para conter a progressão da doença. Alega que em 11/07/2024, exames indicaram agravamento severo, com metástases em ossos, fígado e outras partes do corpo, culminando em alto risco de óbito caso não fosse iniciado tratamento urgente com Enhertu (Trastuzumabe - Deruxtecan), prescrito em 03/07/2024 pela oncologista responsável. Destaca que o medicamento, de alto custo (aproximadamente R$ 80.000 por sessão), requer administração hospitalar em ciclos regulares. Sustenta que solicitou a cobertura à Requerida, que inicialmente não respondeu, levando a uma reclamação à ANS em 30/08/2024. Após meses de demora e descaso, a Requerida negou a cobertura em 20/09/2024, alegando razões técnicas infundadas, como supostas lesões no sistema nervoso central e ausência de comprovação de inexistência de doença cardiovascular, apesar de exames comprobatórios apresentados. Nova solicitação foi feita em 13/09/2024, mas novamente negada, evidenciando resistência injustificada em custear o tratamento. Argumenta que a negativa da Requerida ignorou o histórico clínico da autora, que já havia realizado múltiplos tratamentos quimioterápicos sem sucesso, além de desconsiderar pareceres científicos que comprovam a eficácia do medicamento. Diante da urgência e do risco de morte, a família da Requerente financiou a primeira sessão do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

tratamento (realizada em 26/09/2024) com recursos próprios, no valor de R$ 76.712,52, buscando ressarcimento e continuidade do tratamento. Em nova negativa, a Requerida alegou que o procedimento não está previsto no rol da ANS, desconsiderando o caráter emergencial e o registro do medicamento na ANVISA, além de recomendação do E-NATJUS para sua utilização. Requer a concessão de tutela de urgência para que a ré autorize a realização do tratamento de quimioterapia com a aplicação do medicamento prescrito transtuzumab-deruxtecana – Enhertu. Pugna a procedência da ação confirmando a tutela de urgência, condenando a requerida a cobrir o tratamento da autora nos termos do relatório médico, condenar a ré a restituição do valor de R$ 76.753,52, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora.

Foi deferida a tutela provisória de urgência.

Diante do descumprimento da decisão, foi determinado o sequestro de valores da requerida para o pagamento do tratamento diretamente pela parte autora, com prestação de constas nos autos (fls. 177/178, 195, 339)

A parte requerida foi citada e apresentou contestação, de forma tempestiva, por meio da qual, preliminarmente, impugna o beneficio de justiça gratuita e o valor da causa. No mérito, sustenta que o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana foi excluído da cobertura contratual por se tratar de uso off-label, ou seja, fora das indicações previstas na bula e, portanto, classificado como experimental. Alega que o tratamento oferecido pelo plano de saúde está de acordo com as normativas contratuais e legais, possuindo registro na ANVISA e eficácia comprovada, diferentemente do medicamento pleiteado. Afirma que analisou a solicitação da autora, mas não identificou relatórios médicos completos que justificassem a necessidade do uso do medicamento para o caso específico. Ressalta que tratamentos experimentais, como o pleiteado, não constam no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula as coberturas obrigatórias, e que a exclusão é respaldada pela Resolução Normativa 465 da ANS e pelo artigo 10 da Lei 9.656/98. Além disso, a ré argumenta que o contrato firmado entre as partes é válido e deve ser respeitado, conforme o princípio do pacta sunt servanda, e que a limitação de cobertura para tratamentos off-label é expressamente prevista no contrato e na legislação aplicável. Aponta que a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos fora do rol da ANS somente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

ocorreria mediante registro no SUS ou comprovação de eficácia científica, o que não foi demonstrado neste caso. Aponta a inexistência de danos materiais ou morais. Requer a improcedência (fls. 202/235).

Foi apresentada réplica (fls. 347/373).

O feito foi saneado (fls. 380/384), tendo sido produzida, além da prova documental que acompanhou a manifestação inicial das partes, prova documental consistente em parecer emitido pelo NATJUS (fls. 427/433).

Foi oportunizado às partes se manifestarem sobre a prova produzida, em alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Julgo antecipadamente a lide por prescindir da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do parágrafo 12, da Lei n.º 9.656/98, é obrigatória a cobertura dos tratamentos, medicamentos e procedimentos previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

A Lei n.º 14.454/2022, que alterou a Lei n.º 9.656/98, previu a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos em tal rol em casos excepcionais, fixando parâmetros objetivos para a análise sobre a existência da obrigatoriedade de tal cobertura, nos seguintes termos:

Art. 10 - É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Antes disso, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já havia alterado o entendimento jurisprudencial até então prevalecente, sobre a natureza exemplificativa do rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS.

Em julgamento do EREsp nº 1886929 / SP e EREsp 1889704, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista, tendo fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. Por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Nessa esteira, a princípio, há que se concluir que a ré não se encontra obrigada a cobrir procedimento não previsto no rol de coberturas obrigatórias, editado pela ANS, ou em situação não abarcada pelas diretrizes de utilização previstas no referido rol.

Todavia, tal cobertura se mostra obrigatória quando exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso, de acordo com o relatório médico apresentado pela parte autora, o tratamento que lhe foi prescrito se mostra o mais adequado ao seu estado de saúde, considerando os tratamentos já realizados anteriormente e a falta de eficácia destes (fls. 46):

- Julho/2023: Progressão OSSEA IMPORTANTE- 11/07/2023: Ribociclibe 600 mg + letrozol 2,5 mg + denosumabe até julho/2024 - Julho/2024: progressão óssea/linfonodal/hepática em grande volume.Paciente acima, atualmente com diagnóstico de neoplasia maligna de mama avançada, metastática para ossos (fêmures,bacia, vertebras de coluna torácica e lombar), gradil costal e calota craniana, e atualmente (julho/24), com múltiplas lesões hepáticas sugestivas de metástases até 7,4 cm em novo exame de imagem (tomografia abdome de set/2024).
Prescrito medicação oncológica e solicitado ao convenio ENHERTU em julho/2024, de acordo com estudo fase 3: DESTINY BREAST 04, o qual comprovou aumento de sobrevida, associado a qualidade de vida para o paciente oncológico receptor hormonal positivo e HER 2: LOW.Paciente com doença neoplásica de grande gravidade e alta chance de mortalidade (alto risco de embolia pulmonar e fraturas ósseas), com queda de performance e debilitação precoce. Apresentando no momento queda do estado geral, dores ósseas importantes, piora importante da função hepática, com perda ponderal importante. Atualmente, já em setembro/2024, medicação acima ainda não liberada pelo convenio. Paciente em perda de performance importante, náuseas, vômitos, dores osseas, perda ponderal grave, com dificuldade de exercer as atividades de rotina diárias, com alto risco de óbito se não for tratada adequadamente com urgência.

Requisitado parecer ao Natjus, tal órgão atestou a afirmação do médico que assiste à autora de que o medicamento em questão tem eficácia comprovada para a sobrevida do paciente (fls. 428):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

Para pacientes com tumores endócrino-refratários positivos para receptores hormonais, que são pela imunohistoquímica HER2 (IHC) 1+ ou 2+ e hibridização in situ (ISH) negativa, descobriu-se que o fam-**trastuzumab deruxtecan** (**T-DxD**) melhora a sobrevida livre de progressão (PFS) e a sobrevida global (OS) em comparação com outros regimes de quimioterapia na segunda ou últimas linhas. Oferece-se T-DxD para pacientes com câncer de mama metastático positivo para receptores hormonais e HER2 baixo após progressão com capecitabina e/ou taxano no cenário metastático. Para pacientes com doença pulmonar subjacente grave, o T-DxD pode não ser apropriado devido ao risco de pneumonite com este medicamento – o relatório cita acometimento em arco costal mas sem acometimento pulmonar.

Conquanto tal parecer tenha sido desfavorável à prescrição do medicamento à autora, é certo que atestou a eficácia do fármaco para o fim proposto pelo médico que o assiste, a demonstrar que se encontram preenchidos os requisitos leais para tornar sua cobertura obrigatória (eficácia à luz da ciências).

O parecer desfavorável, no caso, não se mostra suficiente para afastar a adequação e necessidade da prescrição médica que instrui a inicial, tendo em vista que se trata de mero parecer opinativo e não perícia médica especializada, realizada sob o crivo do contraditório, que pressupõe análise específica do caso e de todos os aspectos e circunstâncias que o compõe, considerando o estado de saúde da parte, tratamentos anteriores e prognóstico da doença.

A inércia da parte requerida quanto à produção da prova adequada a afastar a pretensão da consumidora não pode prejudicar esta.

Desta feito, diante das provas produzidas pelas partes, há que se concluir que, embora não previsto tal tratamento no rol de cobertura obrigatória editado pela ANS, preenche a prescrição médica os requisitos necessários a tornar sua cobertura obrigatória.

Considerando que a parte autora realizou parte do tratamento de forma particular, tem direito a ser indenizada pelo quanto pagou para tanto.

A recusa injusta de cobertura de tratamento, além de caracterizar o ilícito da ré, retrata a gravidade de sua conduta.

O inadimplemento de contrato de plano de saúde, quando em questão doença de alta gravidade, capaz de colocar a vida do consumidor em risco ou, ao menos, deixar-lhe lesões irreversíveis e permanentes, como é o caso, é o suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais, pois, por dizer respeito a um dos bens mais caros ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

consumidor, tal negativa lhe causa angustia, temor, ansiedade e aflição, diante da perspectiva de não poder utilizar o tratamento adequado à recuperação de sua saúde.

Com essas considerações e ante as peculiaridades do caso em voga, tendo em vista, especialmente, a intensidade do dano sofrido pela parte autora e o grau de censurabilidade da conduta da parte requerida, arbitro a indenização no valor de R$ 15.000,00, por entender que este é suficiente a ofertar certo conforto à vítima e a coibir comportamentos similares do ofensor no futuro.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados pela autora para condenar a requerida à obrigação de cobrir o tratamento da autora nos termos delineados no relatório médico, consubstanciando em quimioterapia com aplicação do medicamento prescrito - transtuzumab-deruxtecana - Enhertu, sem limitação de ciclos, confirmando, assim, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde desde o arbitramento, e de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária mencionado, a partir da citação; e condenar a requerida ao ressarcimento integral da quantia de R$ 76.723,52, acrescido de correção monetária, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde o desembolso, e de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária mencionado, a partir da citação. Assim, extingo a fase de conhecimento deste processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência preponderante e do princípio da causalidade, invocando, ainda, a Súmula 326, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, condeno as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios da parte contrária que fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

Caso o vencido seja beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Transitado em julgado, antes de se proceder ao arquivamento, atente-se a Serventia para o determina o artigo 1.098, das NSCGJ (Art. 1.098. Os processos findos não poderão ser arquivados sem que o escrivão judicial certifique nos autos estar integralmente paga a taxa judiciária com a respectiva vinculação da guia, os honorários devidos aos órgãos públicos ou entidades conveniadas, a multa prevista no §2º, do art. 77, do Código de Processo Civil e as contribuições, ou sem que faça extrair certidão em que sejam especificadas essas parcelas para fins de inscrição da dívida ativa).

Caso exista algum valor em aberto, nos termos do parágrafo 1º do referido dispositivo, antes da extração da certidão para fins de inscrição na dívida ativa, o escrivão judicial providenciará a intimação do responsável para o pagamento do débito, nos moldes do art. 274 e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não tendo sido atendida a notificação no prazo de 60 (sessenta) dias da expedição da notificação, a certidão extraída será encaminhada à Procuradoria Fiscal, quando se tratar de devedor domiciliado na capital, ou à Procuradoria Regional respectiva, quando se tratar de devedor domiciliado em outra comarca.

Nos casos de gratuidade da justiça, o recolhimento da taxa judiciária correspondente à parte a quem foi concedido o benefício, será realizado pelo vencido, salvo se também for beneficiário da gratuidade, antes do arquivamento dos autos, sob pena de adoção das providências indicadas nos parágrafos anteriores.

Em não havendo o recolhimento, a serventia providenciará a extração da certidão para inscrição na dívida ativa.

Regularizados, e nada mais sendo requerido, independentemente de nova

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
27ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

intimação, arquivem-se os autos, observando-se as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Em caso de pedido de cumprimento de sentença, a parte deve observar as orientações do Comunicado CG nº 1789/2017.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016).

São Paulo, 10 de abril de 2025.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI, liberado nos autos em 10/04/2025 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1167687-39.2024.8.26.0100 e código uMQwrtxy.